

A CORRELAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA E A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE

UNIDADE I

A CORRELAÇÃO ENTRE
A PSICOLOGIA
E A ESPIRITUALIDADE
NA FORMAÇÃO
DA PERSONALIDADE

Unyleya
EDUCACIONAL



Elaboração

Arquiléia Itair Peixoto Gonçalves

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
UNIDADE I	
A CORRELAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA E A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE	7
CAPÍTULO 1	
A COMPREENSÃO DO SER HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE E MULTIDIMENSIONALIDADE ..	9
CAPÍTULO 2	
DIMENSÕES BÁSICAS: FÍSICA, SENSORIAL, EMOCIONAL, MENTAL E ESPIRITUAL.....	14
CAPÍTULO 3	
A COMPREENSÃO DA DIMENSÃO ESPIRITUAL E SUA CORRELAÇÃO COM A PERSONALIDADE..	20
REFERÊNCIAS	25

INTRODUÇÃO



É a sociedade e não a natureza a que deve figurar em primeiro lugar como o fator determinante da conduta do homem (VYGOTSKI, 2000).

A relação existente entre a psicologia e a saúde age diretamente na possibilidade de ampliação da atuação do psicólogo assim como no desenvolvimento de teorias que atendam às necessidades das pessoas. Sabe-se que a psicologia se propõe a integrar a saúde mental, física e social dos indivíduos. Nesse sentido, Camon (2011) afirma que a psicologia é, ao mesmo tempo clínica, hospitalar, social e institucional, apresentando, assim, uma visão abrangente e ampla dos conceitos de saúde.

A esfera social do indivíduo é responsável por absorver os valores da cultura em que está inserido. Nessa mesma linha, Barreto (2012) afirma que a troca de experiências entre os pares, os papéis construídos socialmente e as leis que orientam as condutas individuais e grupais são parte importante da construção da identidade individual.

Além das dimensões mental, física e social, faz parte, também, da formação da identidade individual a dimensão espiritual. Fabry (1984) introduz atributos da dimensão noética na espiritualidade humana, como: a criatividade, a fé, a imaginação, a busca pelo sentido da vida, a possibilidade de transcender a si mesmo. Sobre espiritualidade, Belo (2008) considera que, enquanto caráter universal, demonstra que jamais existiu um ser humano, em qualquer cultura ou região global, que seja desprovido de espiritualidade. Ou seja, o autor afirma que: "O caráter universal da espiritualidade não nega o seu caráter singular. A espiritualidade manifesta-se das mais diferentes e criativas formas, segundo a autenticidade de cada ser humano" (BELO, 2008, p. 30).



Dimensão noética: é o que difere o homem dos demais animais, pois se trata da vivência da liberdade e da responsabilidade (HOLANDA; MOREIRA, 2010, p. 345).

A disciplina "A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade", conteúdo deste caderno de estudos, tem o propósito primeiro de discutir as relações existentes entre a psicologia e espiritualidade e como essa relação pode afetar na formação da personalidade dos indivíduos, a partir da compreensão do ser humano em suas dimensões física, sensorial, emocional, mental e espiritual.

Assim, o conteúdo da disciplina está dividido em quatro grandes unidades, a saber: "A Correlação entre a Psicologia e a Espiritualidade na Formação da Personalidade", "Espiritualidade, psicologia e saúde: uma conexão possível", "O sagrado e o transcendente" e "A espiritualidade na clínica".



- » A primeira unidade introduzirá o tema central da disciplina a partir da compreensão do ser humano em sua integralidade e multidimensionalidade, do estudo das suas dimensões básicas: física, sensorial, emocional, mental e espiritual, e da compreensão da dimensão espiritual a partir dos fenômenos de liberdade, verdade e amor – e sua correlação com a personalidade.
- » A segunda unidade trará a definição psicológica do sentimento religioso, o modelo três grandes (*Big Three*) fatores ou P-E-N, de Hans Eysenck, e o modelo dos cinco grandes (*Big Five*) ou modelo de cinco fatores.
- » A terceira unidade terá como focos a crença e o compromisso com os aspectos transcendentais da vida; o universo, o divino e o sagrado: a convicção em uma existência não material; e o divino encontrado na natureza e no cosmos.
- » A quarta e última unidade abordará o terapeuta como um facilitador, o profissional e o reconhecimento da importância da espiritualidade na clínica e a espiritualidade como facilitadora do processo saúde/doença.

Objetivos

- » Compreender o ser humano em sua integralidade e multidimensionalidade.
- » Compreender as dimensões básicas do ser humano: física, sensorial, emocional, mental e espiritual.
- » Compreender o conceito de espiritualidade e sua relação com a personalidade.
- » Discutir a conexão existente entre espiritualidade, psicologia e saúde.
- » Discutir as interfaces, aproximações e diferenças entre psicologia e religião.
- » Apresentar o modelo três grandes fatores, ou P.E.N., de Hans Eysenck.
- » Apresentar o modelo dos cinco grandes fatores.
- » Analisar a temática da transcendência e da religião.
- » Identificar as implicações referentes à crença e o compromisso com os aspectos transcendentais da vida, na perspectiva de valores capazes de gerar mudanças efetivas nas relações sociais.
- » Analisar a relação entre o universo, o divino e o sagrado.
- » Traçar um paralelo entre o divino encontrado na natureza e no cosmos.
- » Identificar a importância da espiritualidade no cuidado e na atenção ao paciente.

INTRODUÇÃO

- » Analisar as possibilidades do terapeuta como um facilitador.
- » Investigar a influência da fé no processo saúde-doença.



A CORRELAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA E A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE

UNIDADE I

A ciência e a espiritualidade são vistas, há muito tempo, como áreas de conhecimento totalmente distintas e, muitas vezes, opostas. No momento em que vivemos, ainda são predominantes, na dimensão científica, concepções racionalistas e mecanicistas que tendem a não valorizar o que não pode ser mensurado, previsto ou controlado pela razão ou pela tecnologia. Fleck *et al.* (2003) afirmam, em contraposição à essa abordagem, que existem teorias que buscam compreender, de forma mais adequada, os fenômenos espirituais, contribuindo com meios eficazes para analisá-los e estudá-los.

A conexão entre a psicologia e a espiritualidade pode auxiliar os indivíduos na busca por uma melhor qualidade de vida e de saúde. Estudos e pesquisas por formas complementares de tratamento da saúde vêm se tornando cada vez mais intensos e profundos. Assim, a procura por um tratamento integral, incluindo a dimensão espiritual, vem ganhando espaço nos diversos modelos de tratamento para a saúde mental. A própria psicoterapia abriu portas para a retirada do preconceito médico em relação à espiritualidade.

A partir dos novos enfoques holísticos com relação à saúde dos indivíduos, a psicoterapia compreende e recomenda o respeito aos elementos da espiritualidade. Não se trata, porém, da escolha de uma outra religião. A atenção para a espiritualidade ajuda na saúde mental dos pacientes, o que é uma realidade comprovada. O tratamento da saúde física ou mental que integra ciência e espiritualidade proporciona alívio dos sintomas desde as mais graves e severas doenças.

Nesse contexto, a religiosidade tem sido objeto de estudo nas mais variadas áreas de pesquisas científicas. No que se refere à área da saúde, especificamente à psicologia, o fenômeno espiritualidade era visto como preditor no desenvolvimento de psicopatologias. Isso, porque, segundo Almeida (2009), as doutrinas religiosas eram consideradas alienantes e repressoras da sexualidade.

Por outro lado, pesquisas mais recentes atestam que a religiosidade e a espiritualidade apresentam alguns dos aspectos muito significativos da subjetividade humana,



destacando que esses importantes aspectos têm relação com a construção de sentido, bem como com a ordenação da vida dos indivíduos, e que exerce influência também na sua saúde positivamente.

Assim, nesta unidade, discutiremos sobre a compreensão do ser humano em sua integralidade e multidimensionalidade, as dimensões básicas (física, sensorial, emocional, mental e espiritual) e a compreensão da dimensão espiritual a partir dos fenômenos de liberdade, verdade e amor – e sua correlação com a personalidade.



CAPÍTULO 1

A COMPREENSÃO DO SER HUMANO EM SUA INTEGRALIDADE E MULTIDIMENSIONALIDADE

Mesmo considerando que a religiosidade e o sentimento religioso tenham sido amplamente estudados em várias teorias e por muitos autores, o termo espiritualidade é recente e está presente em muitas pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento. De maneira mais popular, espiritualidade é entendida como uma denominação mais profunda da religiosidade, que oferece recursos para o rompimento com as verdades institucionais e doutrinárias, abarcando uma instância superior dos indivíduos com menor relação com rituais e dogmas.

Segundo Koenig (2012), o aspecto espiritual é uma relação com o Sagrado e o transcendente, que relaciona Deus como o fim, associado a um poder supremo, podendo ou não estar ligado com alguma religião. Para Saad (2001), a definição de espiritualidade pode, também, ter ou não afinidade com alguma instituição religiosa e crença; porém, o autor acrescenta na sua definição a busca inerente da espécie humana em conexão com algo maior que ele mesmo, algo que sirva para agregar sentido à sua existência. O autor aponta a diferença da espiritualidade com religiosidade, afirmando que a primeira expressão – espiritualidade – é que dá sentido à religiosidade. É um sentimento que manifesta o interesse pelos outros e por si mesmo, a espiritualidade traz um significado para a vida, oferecendo melhor capacidade para suportar sentimentos próprios, como a raiva, culpa e ansiedade.

Na área da saúde, a expressão integralidade vem sendo utilizada indiscriminadamente, tornando-se a tônica na prestação dos serviços que têm como objetivo a produção de uma nova forma de cuidar. A integralidade é, segundo Pinheiro e Mattos (2004), uma concepção difusa e complexa, extremamente polissêmica. Na Constituição Federal de 1988, o atendimento integral é definido como sendo a necessidade de compreender o indivíduo enquanto um todo holístico, um ser biopsicossocial em sua essência (BRASIL, 1988).

Assim, Mattos e Pinheiro (2004) afirmam que, para a Constituição Federal de 1988, o atendimento integral deve contemplar as necessidades individuais, de maneira ampliada e constitui-se em um desafio na construção do SUS. Sendo assim, a integralidade, segundo Fontoura e Mayer (2006), é o próprio caminho que transforma as pessoas e constrói algo melhor para elas. Ainda, segundo as autoras, a integralidade busca uma assistência ampliada, transformadora, centrada no indivíduo, que não aceita a redução dele nem à doença nem ao aspecto biológico. Integralidade envolve também a valorização do cuidado e o acolhimento.



Seguindo na definição, na Lei n. 8.080/1990 (BRASIL, 1990), o conceito de integralidade ganha maior amplitude, sendo definida como a possibilidade de o indivíduo ter acesso a todos os níveis do sistema de saúde. A referida lei preserva a questão da união entre a prevenção e a cura, acrescentando dois sentidos: o da articulação contínua entre níveis de assistência - atenção primária, secundária e terciária; e o da integração entre o individual e o coletivo.

Art. 7º, II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (BRASIL, 1990).

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) considera a integralidade como sendo a integração entre demanda espontânea e demanda programada no fazer dos serviços de saúde, assim como a mescla gerada pelas atividades clínicas e de campo na Atenção Primária à Saúde (BRASIL, 2011).

Essas formas operacionais para definição do termo integralidade agem na prática do modelo de saúde regido pela Constituição Federal, traduzindo para os profissionais como operar as ações sanitárias de acordo com a filosofia do sistema. No entanto, cabe ressaltar que a integralidade, para atendimento dessas demandas e necessidades construídas, é relacionada àquele contexto.

Nas discussões sobre promoção da saúde e do bem-estar, na atualidade, está em evidência a concepção da integralidade e da multidimensionalidade dos indivíduos. Assim, hodiernamente, não cabe mais a visão sob a perspectiva separativa cartesiana que nos "dividia" em corpos físicos e mentes. Esta é, sem dúvida, uma discussão complexa e desafiadora, tendo em conta que o debate sobre as origens dos seres humanos leva a uma discussão filosófica que mobiliza diversas áreas do conhecimento que são modificadas de acordo com o ritmo rápido e avanço da vida e da ciência.

Sobre multidimensionalidade, tem-se a explicação dada pelo filósofo e educador Ferdinand Röhr, segundo o qual a multidimensionalidade humana ajuda a explicar de forma didática a existência de cinco dimensões básicas dos seres humanos, conforme destalhadas a seguir (RÖHR, 2013).

- » **Física** ou material – constitui-se na pré-condição para manifestação de todas as outras dimensões. É a matéria mais densa, nosso corpo físico-biológico, pela qual circula toda a rede de membros, órgãos e tecidos, produzindo substâncias que nos permitem perceber a existência de outras fontes e formas de energias, como as sensações, as emoções e os pensamentos. O limite mais evidente da dimensão física é o envelhecimento, contra o qual nada se pode fazer. Porém, o envelhecimento é



uma das áreas de estudos que tem tido mais atenção, investimento e dedicação da área da saúde nos séculos XX e início do XXI.

- » **Sensorial** – esta dimensão oferece os sentidos que operam como sensores de captação da realidade ao nosso redor. Captam sensações como calor, frio, dor, prazer; ou seja, todas as percepções recebidas por meio dos órgãos dos sentidos - tato, visão, audição, olfato e paladar. A dimensão sensorial deflagra ações de repulsa ou atração, fuga ou permanência, respectivamente. Essas sensações, porém, não se restringem à esfera do contato; são, também, fontes de informações e sinais para outras dimensões mais sutis, como, por exemplo, a dimensão emocional. Nessa dimensão, o limite é também envelhecimento. Nossas sensações físicas esvaem-se com o avançar da idade.
- » **Emocional** – esta dimensão tem como atribuição ligar o interior e o exterior dos indivíduos e está no centro das experiências e vivências no mundo coletivo. A origem e o manejo das emoções têm implicações formativas, organizacionais e relacionais que não devem ser sufocadas ou negligenciadas. Trata-se aqui da psique, dos estados emocionais e seus movimentos e compensações que oportunizam conhecer um ambiente diverso nas relações que mantemos com nós mesmos, com os outros e com todo o meio em que vivemos. Geram fluxos de energia em todo o corpo em busca de alguma forma de extravasamento. Tal qual as dimensões física e sensorial, sofre as consequências do envelhecimento do corpo. Porém, provavelmente a busca pelo bem-estar emocional como uma meta a ser atingida seja seu maior limite. A falta de compreensão de que o bem-estar emocional é uma vivência leva os indivíduos à possessividade com relação a bens materiais ou às pessoas.
- » **Mental** – esta dimensão permite a criação infinita de imagens da realidade; inventa, desconstrói, compreende e questiona os fenômenos que nos cercam de modo mais racional, lógico e reflexivo. Existe apenas nos seres humanos, que têm a possibilidade de se libertarem das percepções mais imediatas, o que não acontece com os animais irracionais, mas, ao mesmo tempo, impõe limites, como o risco de permanecerem presos por pensamentos ou ideias fixas, reflexos da distorção da realidade; isso acontece por causa da possibilidade da criação de realidades próprias e singulares para cada um de nós. Somos dotados de autoconsciência, criatividade, memória, inteligência e intuição, porém o grande desafio é conhecer nossa própria mente. É preciso lidar com forças internas que questionam, constantemente, sobre o sentido das nossas ações. A racionalidade auxilia na descoberta do mundo de fora, e a intuição oferece condições para realização desse processo, equilibrando necessidades internas e as externas.

- » **Espiritual** - é a responsável por incluir valores religiosos, mas não significa, porém, religião propriamente dita. Trata-se da dimensão que constrói no ser humano valores éticos, faz questionamentos filosóficos e existenciais que são confirmados apenas pela intuição. Através da dimensão espiritual, percebe-se os limites da racionalidade; é quando desperta no indivíduo uma identificação profunda, que vai além do ato mental. Essa dimensão pode ser interpretada pela mente, porém não se baseia na lógica do mundo físico. Exerce função norteadora e possui efeitos traduzidos em saúde, bem-estar, harmonia, justiça e felicidade.

Dimensão é considerada por Röhr (2013) como um território da natureza humana, caracterizado por sinais e funções específicas. Quando colocadas (as dimensões) em contato com as realidades relacionais entre humanos ou animais de outras espécies ou a natureza de forma geral ou pelas realidades que transcendem o mundo das formas, podem ser capturadas por vias intuitivas.

A interferência em qualquer dimensão afeta todas as outras, necessariamente. Isso, porque existe entre elas uma interdependência e uma relação hierárquica. Segundo Röhr (2010), as dimensões física, sensorial, emocional e mental têm seu escopo de ação e seus limites, porém é através de um movimento de expansão e transcendência entre elas que se pode ir além e tornar o indivíduo capaz de atingir/alcançar a dimensão espiritual. Ao alcançar a dimensão espiritual, passa a cultivar, vivenciar e se comprometer com os valores éticos, os questionamentos filosóficos e existenciais, capazes de afetar o cuidado com a própria existência.

De modo objetivo, Arantes (2014) aponta que a dimensão espiritual não busca um caminho evolutivo determinado. Segundo o autor, muito mais que isso, o conhecimento espiritual contempla a participação criativa da mente, do corpo, do coração e da essência mais vital do indivíduo multidimensional no ambiente em que vive. Ferrer (2017) explica que é através dessa participação que o indivíduo se transforma individual e socialmente no intuito de conectar as capacidades que contribuem para um exercício libertário de entendimentos egocêntricos da realidade.

Por essa concepção, Ferrer (2002) explica espiritualidade:

[...] é uma visão de mundo participativa que honra a diversidade e centra-se na identidade coletiva de grupos ou lugares e que, dentre outros princípios, traz a equiprimacia que dialoga diretamente com a multidimensionalidade dos seres, o modo como se compreendem, cuidam de si e da própria saúde. Num âmbito de cocriação intrapessoal, é o princípio da equiprimacia que sugere que a busca do desenvolvimento simétrico das múltiplas dimensões integrantes do ser humano deve ser



sustentada sem que nenhum atributo seja tratado como superior ou mais evoluído que qualquer outro (FERRER, 2002, p. 52).

Segundo Ferrer (2002), o bem-estar do corpo é tão importante quanto o bem-estar da mente e vice-versa. A saúde física e a saúde mental/emocional devem ser tratadas como igualmente relevantes.

Por sua vez, Wilber (2011) explica a multidimensionalidade humana através do Sistema Operacional Integrado (SOI). Esse sistema resume como é feita a organização das informações, sistemas e modelos do desenvolvimento humano sistematizadas ao longo do tempo, da antiguidade até as descobertas atuais das neurociências. O modelo de Wilber foi pensado primeiramente como forma de revelar o potencial dos seres humanos, de impulsionar sua evolução, porém, ao longo do tempo, o pesquisador percebeu que o seu modelo poderia ser aplicado a uma diversidade de campos da atividade humana, como, por exemplo, nas artes, na psicologia, nos negócios, na política, na ecologia, na educação, na espiritualidade etc. O SOI proporciona uma comunicação das diversas áreas de conhecimento, configurando-se num novo tipo de percepção para as experiências vividas.

Lima (2014) afirma que o sistema de Wilber traduz a compreensão da interação das diversas áreas do conhecimento. O autor acrescenta que se trata de uma via em que as verdades de diferentes áreas de conhecimento podem ser dialogadas com uma linguagem conhecida por todas, favorecendo a interligação entre elas. Wilber (2009) considera que quanto melhor se desenvolve o sistema operacional integral, melhor será o resultado da integração das diferentes verdades, das diferentes situações ou dimensões do ser. Na perspectiva de Wilber (2009), cada uma das representações da experiência multidimensional humana encaixa-se às outras interagindo mutuamente.

Em suma, a explicitação das múltiplas dimensões e da visão de seres humanos de forma integral aponta que, para compreender o todo, é preciso compreender as partes e que, para compreender as partes, é preciso compreender o todo. Essa reflexão é, pois, um processo de cultivo ao autoconhecimento, de vivências e dinâmico, levando à compreensão sobre o que constitui o ser humano, favorecendo sua tomada de consciência de sua singularidade e a conexão dos indivíduos uns com os outros e com o ambiente.

CAPÍTULO 2

DIMENSÕES BÁSICAS: FÍSICA, SENSORIAL, EMOCIONAL, MENTAL E ESPIRITUAL

Röhr (2013) afirma que o ser humano possui múltiplas dimensões e que essas dimensões podem ser categorizadas em básicas e transversais. As básicas, para o autor, são:

- » física;
- » sensorial;
- » emocional;
- » mental;
- » espiritual.

As dimensões física, sensorial, emocional e mental fazem parte do campo imanente do ser humano; já a espiritual reside no campo do transcendental.



Imanência e transcendência

- » **Imanência** - refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e seu fim. Está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo
- » **Transcendência** – refere-se a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A transcendência está ligada à realidade imaterial, de uma natureza metafísica e puramente teórica e racional.

As dimensões transversais são:

- » relacional-social;
- » estético-artística;
- » político-econômica;
- » comunicativa;
- » místico-mágico-religiosa;
- » sexual-libidinal;
- » volutivo-impulsional-motivacional;
- » ética;

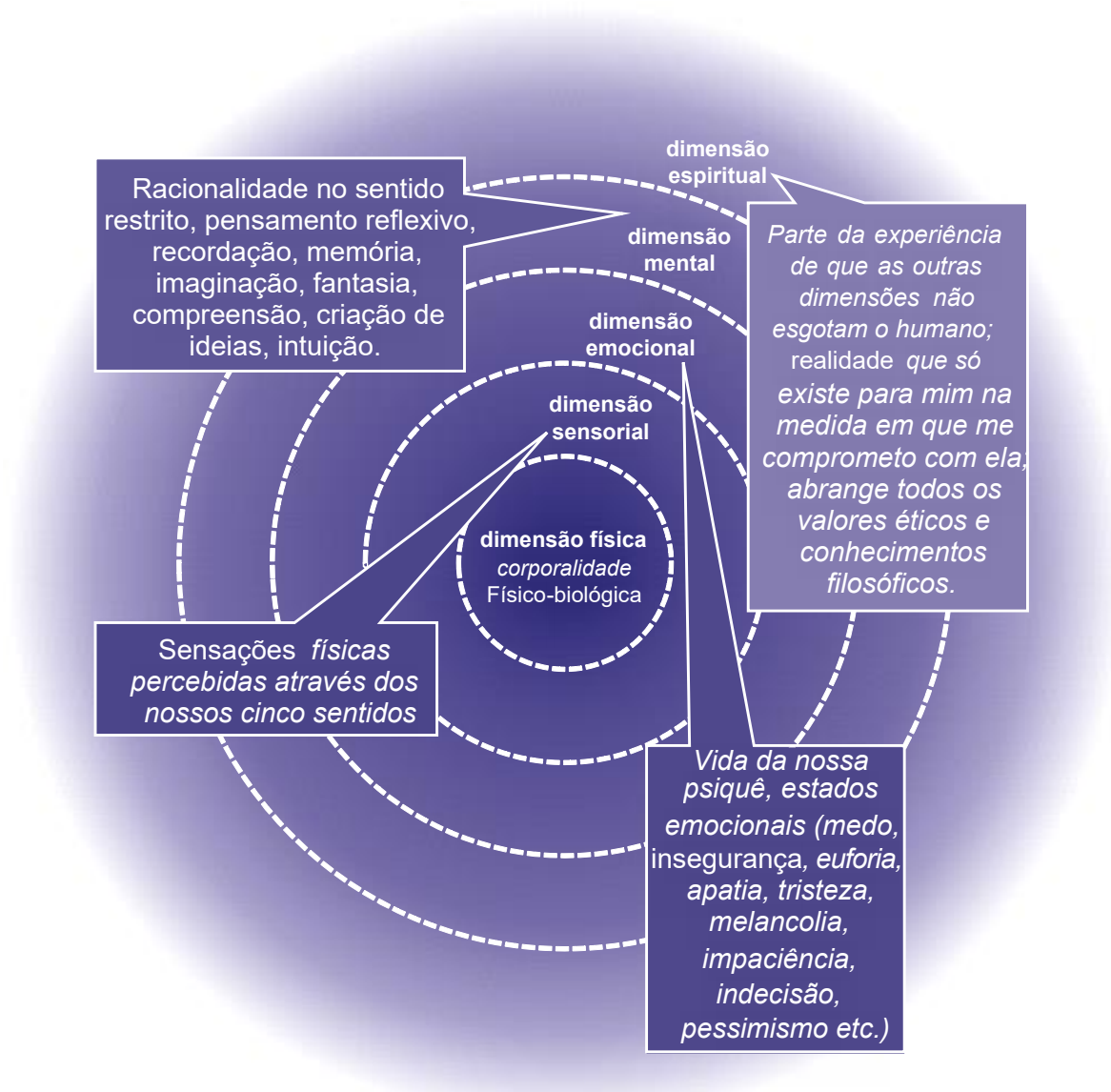


- » gênero;
- » lúdica;
- » ecológica;
- » étnica;
- » prático-laboral-profissional (RÖHR, 2013).

O autor não fecha questão sobre as dimensões transversais, deixando aberta a possibilidade para inclusão de outras dimensões, além das relacionadas por ele.

Neste capítulo, serão discutidas apenas as dimensões básicas do ser humano.

Figura 1. Dimensões básicas do ser humano.



Fonte: Röhr, 2013.

2.1. Dimensão física

A dimensão física do ser humano inclui a corporalidade físico-biológica, da qual, em parte, nem temos percepção. Tem início no momento da concepção, ou seja, é fruto da relação de duas pessoas, uma masculina e outra feminina. É a parte mais densa do indivíduo, é como nos vemos no espelho.

A dimensão física tem ligação direta com o nosso corpo, com o nosso bem-estar físico e com a nossa saúde. É por isso que tanto se propaga a necessidade do desenvolvimento de hábitos saudáveis para o cultivo da inteligência. O cuidado e o tratamento dessa dimensão auxiliam na melhora da autoestima, na coordenação das outras dimensões e na performance cotidiana.

Outra característica da dimensão física é que tem um período de formação, que vai, geralmente, do nascimento até, por volta, dos 17 anos. Aos 17 anos, de modo geral, os órgãos e as funções do corpo atingem a plenitude do desenvolvimento.

Após esse período, em torno de 17 anos, tem início o envelhecimento do corpo. A velocidade do envelhecimento do corpo depende diretamente dos cuidados que a pessoa tem com ele, com sua saúde. As cirurgias plásticas, por exemplo, desenvolvem apenas a aparência mais jovial, porém não evitam que os órgãos do corpo entrem numa curva descendente de performance.

O corpo é a ferramenta física que permite o indivíduo realizar ações voluntárias e involuntárias e estabelecer relações com outros seres, humanos ou não humanos. A dimensão física adquire maior importância a partir da forma como o indivíduo se identifica. Ou seja, depende dos hábitos adotados pelas pessoas para garantia da manutenção saudável do corpo, protegendo-o e impedindo que ele seja prejudicado.

Entre os hábitos que podem ser adotados para evitar que a dimensão física seja afetada negativamente, estão uma dieta saudável, atividades esportivas e cuidados clínicos gerais com a saúde.

2.2. Dimensão sensorial

Esta dimensão representa as sensações físicas – calor e frio, dor e prazer físicas, doce e amargo, sedoso e áspero, cheiroso e fedorento etc. A dimensão percepção é responsável pelos cinco sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. Ela atua diretamente nas ações de repulsa ou atração, fuga ou permanência.

A dimensão sensorial está diretamente ligada ao meio ambiente. Assim, todo ser humano experimenta, diariamente, diversas sensações e estímulos no seu corpo. As informações



captadas pelos sentidos chegam ao cérebro através de receptores sensoriais, que servem para o organismo explorar e interpretar o mundo exterior. Não estão restritas apenas à esfera do contato físico; atuam, também, como fontes de informações e sinais para dimensões mais sutis, como a emocional.

Embora existam animais com sentidos mais aguçados que os do homem, como, por exemplo, o olfato dos cães ou a visão das águias, nenhum animal desenvolveu uma combinação de sentidos tão abrangente como a que tem o ser humano. A capacidade de sobrevivência do ser humano está relacionada, diretamente, com a integração e a harmonia dos diversos sentidos com o ambiente.

Para essa dimensão, assim como a dimensão física, o envelhecimento é o limite. As sensações físicas esvaem-se com o avançar da idade (CORDEIRO, 2012).

Figura 2. Os cinco sentidos humanos.



Fonte: <https://www.shutterstock.com/pt/image-vector/illustration-kids-holding-five-senses-flash-1383756728>.

2.3. Dimensão emocional

A dimensão emocional contempla a psique e abrange os estados emocionais (o medo, a insegurança, a euforia, a apatia, a tristeza, a melancolia, a impaciência, a dispersão, a solidão, a saudade, a indecisão, o pessimismo etc.) e suas respectivas consequências. Agem oportunizando o conhecimento de um ambiente diverso nas relações dos indivíduos com eles mesmos, com os outros e com todo o meio em que vive. Gera fluxos de energia em todo o corpo na busca de alguma forma de extravasamento.

Sobre o tema, Casassus (2009) destaca que essa dimensão é responsável por conectar o interior e o exterior dos indivíduos e está no centro das experiências e vivências no mundo coletivo. O autor acrescenta que a origem e o manejo das emoções têm implicações formativas, organizacionais e relacionais que não podem ser sufocadas ou negligenciadas.

A dimensão emocional pode ser compreendida como a capacidade de o indivíduo lidar com as emoções e os sentimentos que estão subjacentes nas relações intrínsecas,

extrínsecas ou em ambas. É responsável pela capacidade do ser humano de realizar ações geradas pelo estado psicológico, vinculando sentimentos a uma situação específica.

O desenvolvimento da dimensão emocional implica o reconhecimento das próprias emoções e das emoções das pessoas que estão ao seu redor, para formação de uma maneira de agir mais conveniente possível.

Assim como as dimensões física e sensorial, a emocional sofre as consequências do envelhecimento do corpo. Cordeiro (2012) afirma que a falta de compreensão de que o bem-estar emocional é uma vivência provoca sofrimento com tendências à possessividade, seja de bens materiais ou com relação aos outros.

2.4. Dimensão mental

A dimensão mental inclui, primeiramente, a questão racional e lógica no sentido mais restrito. Nesse sentido, essa dimensão corresponde:

- » aos pensamentos universais, formais – lógica e matemática;
- » à capacidade de reflexão – questionamento de todas as coisas, inclusive sobre si mesmo;
- » à recordação e à memória;
- » à imaginação e à fantasia;
- » à compreensão e à criação de ideias;
- » à nossa intuição – quando sabemos sem poder justificar, em última instância, porque sabemos.

A dimensão mental permite a criação infinita de imagens da realidade, inventadas e desconstruídas, abrange o questionamento dos fenômenos que cercam o universo de forma mais racional, mais lógica e mais reflexiva. Existe apenas nos seres humanos; diferentemente dos animais, os seres humanos têm a possibilidade de se libertarem das percepções mais imediatas. Os limites impostos por essa capacidade, inerentes aos seres humanos, são o risco da criação de pensamentos e ideias fixas oriundas da distorção da realidade, considerando a possibilidade da criação/invenção das próprias realidades.

O ser humano é dotado de autoconsciência, criatividade, memória, inteligência e de intuição. Porém, tem-se como grande desafio o desbravamento da sua própria mente. É preciso administrar as forças internas que questionam constantemente o sentido das nossas ações/decisões. Cordeiro (2012) afirma que a racionalidade ajuda a descobrir o mundo de fora e a intuição dá condições para realização desse processo equilibrando, as necessidades internas e as externas.



Figura 3. Dimensão mental.



Fonte: <https://www.sociomotiva.com/pt-BR/pages/04f799e9-cd58-4333-9ac1-a07d4b69777b>.

2.5. Dimensão espiritual

A dimensão espiritual é mais difícil de identificar. Não se pode confundir espiritualidade com religiosidade. A religiosidade pode incluir a espiritualidade no seu funcionamento, porém aquela contempla algumas características, como, por exemplo, intervenção direta de Deus, que são estranhas ou desnecessárias à dimensão espiritual.

O ser humano pode aproximar-se da dimensão espiritual a partir da falta de identificação ou da insuficiência de explicações das outras dimensões em relação às possibilidades terrenas. Ou seja, é capaz de viver nas dimensões primeiras sem estar comprometido com nenhum aspecto delas. Porém, acessa a dimensão espiritual quando se identifica com algum aspecto que se torna um apelo incondicional para ele.

A dimensão espiritual é responsável pelos valores religiosos, é o campo dos valores éticos, dos questionamentos filosóficos e existenciais confirmados pela intuição. É a percepção dos limites da racionalidade, ou seja, a sensação de algo que desperta uma identificação profunda, além de um mero ato mental. Essa dimensão pode ser interpretada pela mente, porém opera de forma diferente da dimensão mental. Isso se justifica porque ela não se baseia na lógica evidenciada pelas verdades do mundo físico, atua como função norteadora e seus efeitos são percebidos pela saúde, pelo bem-estar, pela harmonia, pela justiça e pela felicidade.

CAPÍTULO 3

A COMPREENSÃO DA DIMENSÃO ESPIRITUAL E SUA CORRELAÇÃO COM A PERSONALIDADE



“A existência sem um sistema de valores é patogênica. O ser humano necessita de uma trama de valores, de uma filosofia de vida, de uma religião ou de um substitutivo da religião de acordo com o qual viva e pense” (MASLOW, 1983, p.271).

Mesmo antes do século XIX ou a partir dele, as áreas da psicologia e da psiquiatria tentam compreender as diversas faces da espiritualidade de forma negativa, traduzidas como transtornos mentais ou o envolvimento dos indivíduos com os fenômenos espirituais como sendo indicadores de patologias ou de retardo mental. Os aspectos centrais da teoria de Freud, o determinismo e o inconsciente, e o foco dado na ciência do Behaviorismo são as críticas mais ferrenhas dos novos movimentos da psicologia.

Assim, segundo Moreira-Almeida e Cardeña (2011), Freud considerava as vivências espirituais como uma neurose obsessiva. No DSM-III, as vivências de cunho espiritual foram concebidas como episódio psicótico e psicose borderline. Por outro lado, podem-se encontrar, também, abordagens favorecedoras do tema que emergiram no último século, como, por exemplo, as noções colocadas por William James, Jung, Maslow, Hood e Caird.

- » **William James** - segundo Ryan (2008), James apresentou quatro grandes contribuições para o campo da transpessoalidade: primeiro, o seu interesse na experiência psíquica e religiosa; segundo, a sua definição da verdadeira ciência e sua refutação do materialismo; terceiro, por seu conceito de consciência; e quarto, pela sua defesa da validade da experiência espiritual.
- » **Carl Jung** - considerou as experiências espirituais como manifestação de uma experiência psicologicamente saudável. Segundo Machón (2016), Jung defende que a alma é a própria inteligência, independente de tempo e espaço. Jung (1978) afirma que o número de fatos que apoiam a existência da alma é imenso; a negação dessa existência torna impossível a consciência dos fatos que cercam a totalidade da vida humana. Assim, a alma precisa existir e ser investigada, de forma profunda, para melhor compreender os processos psíquicos que envolvem o ser humano.
- » **Maslow** – referiu-se às experiências culminantes enquanto expressão máxima da saúde e do bem-estar psicológico. A teoria de Maslow reflete, de maneira objetiva, as necessidades humanas e suas implicações na motivação do indivíduo. Porém, Maslow não ficou plenamente satisfeito com sua teoria, pois julgava faltar algo, que seria, para ele, o elemento básico do ser humano: a espiritualidade.



- » **Hood (1976) e Caird (1987)** - constataram que pessoas que discursam sobre sua espiritualidade – em razão de exercerem-na – pontuam mais em escalas de bem-estar psicológico e menos em escalas de psicopatologia.

Assim, ao longo dos tempos, a espiritualidade sempre teve um papel fundamental nas nossas vidas. A psicologia tem tentado determinar até onde vai a importância desse fenômeno na vida das pessoas, a sua relação com a personalidade. Pesquisa e estuda, também, como espiritualidade e personalidade podem ser mutuamente influenciadas.

O estudo da personalidade é um dos maiores campos da psicologia. Sempre tentou observar como a personalidade se forma, como afeta o comportamento do indivíduo e como condiciona a forma de visão do mundo. Por isso, a relação existente entre a personalidade e a espiritualidade tem sido cada vez mais pesquisada.

As pesquisas sobre espiritualidade apontam que a religião tem um papel significativo na vida das pessoas, independentemente dos avanços nas áreas da educação, da psicologia e da medicina. Exemplos disso são estudos que encontram resultados positivos demonstrando que as crenças e as práticas religiosas são estratégias eficientes de pacientes e seus cuidadores para lidar com o sofrimento causado pelas doenças.

Nesse processo, Koenig *et al.* (2001) elucidaram que 80% dos estudos revisados apontam para relações positivas entre religiosidade e bem-estar. Além disso, os autores encontraram, também, que estudos prospectivos, semiexperimentais e experimentais, sugerem que atividades religiosas e/ou espirituais reduzem os sintomas do transtorno da depressão e que as psicoterapias seculares e as de orientação religiosa apresentam a mesma efetividade.

Como sinônimo de avanço, nesse sentido, o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais - DSM-IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995) incluiu os fenômenos relacionados à esfera religiosa e espiritual do comportamento humano. Ainda, como sinônimo de avanço científico, segundo Fleck *et al.* (2003), a Organização Mundial da Saúde incluiu um domínio denominado religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais em seu instrumento de avaliação de qualidade de vida, o WHOQOL.

A investigação das relações entre personalidade/psicologia e religiosidade/espiritualidade têm sido feitas a partir de dois modelos principais originados de taxonomias de traços de personalidade.

- » O primeiro é conhecido como três grandes (*Big Three*) fatores ou P-E-N, de Hans Eysenck.
- » O segundo é o modelo dos cinco grandes (*Big Five*) ou modelo de cinco fatores.

O modelo três grandes fatores, de Hans Eysenck, baseia-se em dois aspectos centrais para o estudo da personalidade: o primeiro, descritivo, taxonômico e biológico, é responsável pelas diferenças individuais e fundamentais da personalidade; o segundo, causal, é o resultado da aprendizagem e do meio ambiente do indivíduo.

O segundo modelo, o de cinco grandes fatores de personalidade, baseou-se nas pesquisas de R. B. Cattell, que é considerado, segundo Hall, Lindzey e Campbell (2000), seu “pai intelectual”. As análises fatoriais da personalidade do modelo proposto por Cattell se fundamentaram na chamada hipótese léxica, ou seja, colher informações a partir de expressões encontradas na linguagem natural das pessoas. Segundo Silva *et al* (2007), Cattell encontrou em torno de 16 fatores que descreviam a personalidade.



O estudo dos modelos três grandes fatores e os cinco grandes fatores será aprofundado, respectivamente, nos Capítulos 2 e 3 da Unidade II.

A partir do método proposto por Cattell, segundo Goldberg (1990), estudos analisaram a estrutura da personalidade e chegaram a apenas cinco fatores que oferecem maior confiabilidade. Finalmente, a denominação dos fatores foi a proposta por Costa e McCrae (1995): extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, conscienciosidade e amabilidade.

3.1. Espiritualidade seria o sexto fator de personalidade

Piedmont (1999) considerou três critérios principais para demonstrar que as variáveis espirituais representam dimensões diferentes das que o modelo de cinco fatores contempla. Segundo o autor, a primeira nova dimensão da personalidade precisa ser independente das cinco já existentes; a segunda nova dimensão precisa estar num nível de generalidade e abrangência comparável com às outras cinco, assumindo muitas facetas menores; por fim, a terceira nova dimensão deve ser recuperável, sobrevivendo às múltiplas fontes de informação, por meio de fontes de classificação e de medidas.

Em seus estudos, Piedmont (1999) buscou desenvolver uma escala que contemplasse medidas que capturassem aspectos do indivíduo que fossem independentes das qualidades expressas no modelo de cinco fatores. O modelo proposto pelo autor foi denominado de escala de transcendência espiritual.

Para seus estudos, Piedmont (1999) considerou transcendência espiritual como:

- » um senso de conectividade com toda a raça humana;
- » universalidade, crença na natureza unitiva de toda a vida;



- » rezar, ter sentimentos de alegria e contentamento, que resultam de encontros pessoais com uma realidade transcendente.

Na mesma linha de estudo de Piedmont, McDonald (2000) investigou a existência de uma estrutura fatorial significativa que fundamentasse a espiritualidade e a associação dessa estrutura com a personalidade. O pesquisador encontrou cinco dimensões significativas da espiritualidade, quais sejam:

- » orientação cognitiva – esta dimensão inclui crenças, atitudes e percepções a respeito da natureza e da importância da espiritualidade;
- » dimensão experiencial/fenomenológica da espiritualidade – contempla experiências que são descritas como espirituais, religiosas, místicas, de pico, transcendentais e transpessoais;
- » bem-estar existencial – considera o sentido e o propósito para a existência e a percepção de si mesmo como sendo capaz de lidar com as dificuldades da vida e com as limitações da existência humana;
- » crenças paranormais – crenças em precognição, psicocinese, espiritualismo, fantasmas e aparições;
- » religiosidade – expressão da espiritualidade por meio de significados e símbolos religiosos.

Para avaliação dessas dimensões, o instrumento de McDonald (2000) foi validado e denominado inventário de expressões de espiritualidade.

Nesse caminho, Cloninger, Svrakic e Przybeck (1993) desenvolveram o modelo psicobiológico de temperamento e caráter. Os autores consideraram que o modelo de cinco fatores não captura dimensões consideradas fundamentais para a compreensão de transtornos de personalidade. Segundo os autores, o modelo de cinco fatores não é capaz de definir a estrutura causal subjacente à variabilidade biológica e social dos traços de personalidade. Por isso, como solução, propõem um modelo alternativo, que contempla as dimensões biológicas e sociais subjacentes, incluindo quatro determinantes de temperamento e três de caráter.

No modelo de Cloninger, Svrakic e Przybeck (1993), as dimensões de temperamento, de base hereditária, são:

- » busca pelo novo;
- » evitação de sofrimento;
- » dependência de recompensas;

- » persistência.

As dimensões de caráter, ligadas às questões sociais, ao autoconceito e ao aprendizado, são:

- » autodiretividade – refere-se à autonomia e à presença ou ausência de transtorno mental;
- » cooperatividade – refere-se ao sentimento de fazer parte da humanidade como um todo;
- » autotranscendência – refere-se à sensação de fazer parte do universo como um todo e à espiritualidade.

A dimensão autotranscendência é considerada um processo de desenvolvimento que tem relação com a aceitação da espiritualidade e a identificação com o que está além do *self* individual. Sofre influência, ainda, da perda das fronteiras entre o *self* e os outros por meio da identificação com o conceito de um Deus imanente, que está em tudo.

A autotranscendência, segundo Cloninger, Svrakic e Przybeck (1993), divide-se em cinco estágios, que são:

- » esquecimento do *self* X egocentrismo;
- » identificação transpessoal X individualismo;
- » aceitação espiritual X materialismo racional;
- » iluminação X objetividade;
- » idealismo X praticidade.

Cloninger, Svrakic e Svrakic (1997) desenvolveram o inventário de temperamento e caráter (ITC). Os autores alegam que baixos escores nas escalas de caráter estão associados com irresponsabilidade, baixo controle de impulsos e transtornos de personalidade; escores baixos no fator cooperatividade estão associados a déficits de empatia, hostilidade, agressividade e oportunismo; por fim, escores baixos de autotranscendência estão associados a comportamentos materialistas com pouca ou nenhuma preocupação com ideais, como bondade e harmonia universal.



Leia o artigo “Espiritualidade e religião: tópicos de psicologia positiva”, de José H. Barros-Oliveira, disponível no link: <https://www.positivapsicologia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Espiritualidade-e-religi%C3%A3o.pdf>



REFERÊNCIAS

- ADAMS, D. **O guia do mochileiro das galáxias**. São Paulo: Arqueiro, 2010.
- ALES BELLO, A. **Fenomenologia e ciências humanas**. Baurur: EDUSC, 2004.
- ALLPORT, G. W. **Personalidade padrões e desenvolvimento**. São Paulo: Herder; Editora da Universidade de São Paulo, 1966.
- ALMEIDA, A. A. S.; ODA, A. M. G. R.; DALGALARRONDO, P. O olhar dos psiquiatras brasileiros sobre os fenômenos de transe e possessão. **Rev. Psiquiatr. Clín.**, v. 34, n. 1, pp. 34-41, 2007.
- ALMEIDA, M. S. P. A natureza entre Oriente e Ocidente: uma leitura de Grande Sertão: Veredas e as perspectivas filosófico-culturais. **Rios Eletrônica - Revista Científica da FASETE**, ano 7, 2013.
- ALMEIDA, R. **A Igreja Universal e seus demônios**. São Paulo: Terceiro Nome, 2009.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-IV**: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Trad. Dayse Batista. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 1995.
- ANANDARAJAH, G.; HIGHT, E. Spirituality and medical practice: using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment. **Am. Fam. Physician.**, v. 63, n. 1, pp. 81-89, 2001.
- ANCONA-LOPEZ, M. Psicologia e religião: recursos para construção do conhecimento. **Revista Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 19, n. 2, pp. 78-85, maio/ago. 2002.
- ANCONA-LOPEZ, M. Religião e psicologia clínica: quatro atitudes básicas. In: MASSIMI, M. E.; MAHFOUD, M. (org.). **Diante do mistério**. São Paulo: Edições Loyola, pp. 71-86, 1999.
- AQUINO, T. A. A. Atitude religiosa e crenças dos alunos de psicologia. **Revista da Unipê**, v. 9, n. 1, pp. 56-63, 2005.
- AQUINO, T. A. A. **Logoterapia e análise existencial**: uma introdução ao pensamento de Viktor Frankl. São Paulo: Paulus, 2013.
- ARANTES, M. M. **O (des)conhecimento sobre a influência das emoções na relação professor-aluno**. 2014. 189 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- ARANTES, M. M.; FERREIRA, A. L. Reflexões sobre o ser humano integral e a concepção de saúde. **Rev. Enferm. Digit. Cuid. Promoção Saúde**, v. 4, n. 2, pp. 140-145, jul./dez 2019.
- BARCELLOS, J. C. **Literatura e espiritualidade**: uma leitura de Jeunes Années, de Julien Green. São Paulo: EDUSC, 2001.
- BARRETO, R. A. D. N. **Fundamentos antropológicos e sociológicos**. Aracaju: Fits, 2012.
- BARROS-OLIVEIRA, J. H. Espiritualidade e religião: tópicos de psicologia positiva. **Psicologia Educação e Cultura**, v. XI, n. 2, pp. 265-287, 2007. Disponível em: <https://www.positivapsicologia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Espiritualidade-e-religi%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2022.
- BELO, R. A. **Espiritualidade**: dialógica e experimental – a perspectiva da psicologia fenomenológica existencial diante da espiritualidade humana. Maceió: EDUFAL, 2008.
- BERGER, P. **O dossel sagrado**: elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulinas, 1985.

REFERÊNCIAS

- BERGIN, A.; PAYNE, I. R.; RICHARDS, P. S. Values in psychotherapy. *In*: SHAFRANSKE, E. P. **Religion and the clinical practice of psychology**. Washington, D. C.: American Psychological Association, 1996. Cap 11.
- BLANCH, A. Integrating religion and spirituality in mental health: the promise and the challenge. **Psychiatric Rehabilitation Journal**, v. 30, pp. 251-260, 2007.
- BOFF, L. **Espiritualidade**: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
- BORGATTA, E. F. The structure of personality characteristics. **Behavioral Science**, v. 12, pp. 8-17, 1964.
- BOSCAGLIA, N. *et al.* The contribution of spirituality and spiritual coping to anxiety and depression in women with a recent diagnosis of gynecological cancer. **Int. J Gynecol. Cancer**, v. 15, n. 5, pp. 755-761, 2005.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.
- CAIRD, D. Religion and personality: are mystics introverted, neurotic or psychotic? **Br J Soc. Psychol.**, v. 26, pp. 345-346, 1987.
- CALVETTI, P. U.; MULLER, M. C.; NUNES, M. L. T. Psicologia da saúde e psicologia positiva: perspectivas e desafios. **Psicologia, Ciência e Profissão**, v. 27, n. 4, pp. 706-717, 2007.
- CAMON, V. A. A. O papel da espiritualidade na prática clínica. *In*: CAMON, V. A. A. **Novos rumos na psicologia da saúde**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
- CAMON, V. A. A. O ressignificado da prática clínica e suas implicações na realidade social. *In*: CAMON, V. A. A. **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- CASASSUS, J. **Fundamentos da educação emocional**. 1. ed. Brasília: Unesco; Liber Livro, 2009.
- CECCARELLI, P. R. Mitologia e perversão. *In*: PASTORI, S.; NICOLAU, R. (org.). **Encontro transcultural**: subjetividade e psicopatologia no mundo globalizado. pp. 61-88. São Paulo: Escuta, 2012.
- CHARBAJE, R. R. *et al.* Budismo: movimento religioso de respeito à natureza. **Sinapse Múltipla**, ano 2, n. 1, pp. 22-26, jun. 2013.
- CHIATTONE, H. B. C. A significação da psicologia no contexto hospitalar. *In*: CAMON, V. A. A. (org.). **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. pp. 145-241, Cap. 5. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- CLONINGER, C. R.; SVRAKIC, N. M.; SVRAKIC, D. M. Role of personality self-organization in development of mental order and disorder. **Dev. Psychopathol.**, v. 9, pp. 881-906, 1997.



- CLONINGER, C. R.; SVRAKIC, D. M.; PRZYBECK, T. R. A psychobiological model of temperament and character. **Arch. Gen. Psychiatry**, v. 50, 1993.
- CORDEIRO, E. P. B. **Formação humana para jovens e adultos**: elaboração, implementação e teste de um componente curricular em cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tese (Doutorado em História e Filosofia da Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.
- COSTA, P. T.; MCCRAE, R. R. Primary Traits of Eysenck's P-E-N System: Three- and Five-Factor Solutions. **Personality Processes and Individual Differences**, v. 69, n. 2, pp. 308-317, 1995.
- CURLIN, F. A. *et al.* Religion, conscience, and controversial clinical practices. **The New England Journal of Medicine**, v. 356, n. 6, pp. 593-600, 2007.
- DURKHEIM, E. **As formas elementares da vida religiosa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- ELIADE, M. **O sagrado e o profano**: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- ERTHAL, T. C. S. A luz da sabedoria na psicoterapia. In: CAMON, V. A. A. (org.). **Espiritualidade e prática clínica**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- EVARISTO, P. **A Presença de Deus em Gênesis e Êxodo**. Dissertação de Mestrado não publicado. São Paulo: Faculdade Teologia Batista em São Paulo, 1997.
- EYSENCK, H. J. **The structure of human personality**. London: Methuen, 1953.
- EYSENCK, H. J. **Estudio científico de la personalidad**. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1959.
- FABRY, J. B. **A busca do significado**. Tradução Equipe da ECE. São Paulo: ECE, 1984.
- FARRIS, R.; ROSA, R. S. Religião salugênica e religião patogênica: uma aproximação à luz da psicologia. **Revista Pistis & Praxis, Teologia e Pastoral**, v. 3, n. 2, pp. 361-382, 2011.
- FERRER, J. N. **Participation and the mystery**: transpersonal essays in psychology, education, and religion. New York: State University of New York Press, 2017.
- FERRER, J. N. **Revisioning transpersonal theory**: a participatory vision of human spirituality. New York: State University of New York Press, 2002.
- FISKE, D. W. Consistency of the factorial structures of personality ratings from different sources. **Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 44, pp. 329-344, 1949.
- FLECK, M. P. A. *et al.* Desenvolvimento do WHOQOL, módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, pp. 446-455, 2003.
- FLOR DE LÓTUS: conheça as curiosidades da planta oriental. Viva Decora Blog, 26 set. 2018. Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/revista/flor-de-lotus/>. Acesso em: 12 nov. 2022.
- FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- FONTOURA, R. T.; MAYER, C. N. Uma breve reflexão sobre a integralidade. **Rev. Bras. Enferm.**, v. 59, n. 4, pp. 532-537, jul./ago. 2006.
- FRANCA, L. **A psicologia da fé**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 2000.

REFERÊNCIAS

- FRANKL, V. E. **Em busca de sentido**: um psicólogo no campo de concentração. São Leopoldo: Sinodal; Petrópolis: Vozes, 1994.
- FRANKL, V. E. **A psicoterapia na prática**. São Paulo: Papirus, 1991.
- FREITAS, M. H. Psicologia religiosa, psicologia da religião/espiritualidade, ou psicologia e religião/espiritualidade? **Revista Pistis & Praxis – Teologia e Pastoral**, v. 9, n. 1, pp. 89-107, 2017.
- FREUD, S. (1910) Atos obsessivos e práticas religiosas. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
- GAARDER, J.; HELLERN, V.; NOTAKER, H. **O livro das religiões**. 10. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.
- GARCÍA, L. F. Teorias psicométricas da personalidade. *In*: Flores-Mendoza, C.; Colom, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 219-241. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- GASPAR, K. C. Psicologia hospitalar e a oncologia. *In*: CAMON, V. A. A. (org.). **Psicologia da saúde**: um novo significado para a prática clínica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- GIOIA-MARTINS, D.; ROCHA JÚNIOR, A. Psicologia da saúde e o novo paradigma: novo paradigma? **Psicologia: Teoria e Prática**, v. 3, pp. 35-42, 2001.
- GIUSSANI, L. **O senso religioso**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
- GOLDBERG, D. T. Poluting the body politic: racist discourse and urban location. *In*: CROSS, M.; KEITH, E. M. **Racism, the City and the State**. pp. 45-60. London; New York: Routledge, 1993.
- GOLDBERG, L. R. An alternative “description of personality”: the Big-Five Factor Structure. **J Pers. Soc. Psychol.**, v. 59, n. 6, pp. 1216-1229, 1990.
- GUIMARÃES, H. P.; AVEZUM, Á. O impacto da espiritualidade na saúde física. **Rev. Psiq. Clín.**, v. 34, supl 1, pp. 88-94, 2007.
- HALL, C. S.; LINDZEY, G.; CAMPBELL, J. B. **Teorias da personalidade**. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- HEFTI, R. Integrando espiritualidade no cuidado com a saúde mental, psiquiatria e psicoterapia. **Interação em Psicologia**, Curitiba, v. 23, n. 2, ago. 2019.
- HELLERN, V.; NOTAKER, H.; GAARDER, J. **O livro das religiões**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- HOLANDA, A.; MOREIRA, N. Logoterapia e o sentido do sofrimento: convergências nas dimensões espiritual e religiosa. **Psico-USF**, v. 15, n. 3, pp. 345- 356, set./dez. 2010.
- HOOD, R. W. Conceptual criticism of regressive explanations of mysticism. **Rev. Religious Res.**, v. 17, pp. 179-188, 1976.
- HUTZ, C. S. *et al.* O desenvolvimento de marcadores para a avaliação da personalidade no modelo dos cinco grandes fatores. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 11, n. 2, pp. 395-411, 1998.
- JAMES, W. **The varieties of religious experience**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1902.
- JUNG, C. G. **Psicologia e religião**. Tradução do Pe. Dom Mateus Ramalho Rocha; revisão técnica de Dora Ferreira da Silva. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
- JUNG, C. G. **Psicologia e religião**. Petrópolis, RJ: Vozes, Petrópolis, 1978. (Obras completas de C. G. Jung, v. 11/1).



- KOENIG, H. G. **Medicina, religião e saúde**: o encontro da ciência e da espiritualidade. Tradução de Iuri Abreu. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012.
- KOENIG, H. G. **A espiritualidade no cuidado com o paciente**: por que, quando, como e o que. São Paulo: FE, 2005.
- KOENIG, H. G. Religion and medicine II: religion, mental health, and related behaviors. **Int. J Psychiatry Med.**, v. 31, n. 1, pp. 97-109, 2001.
- KOENIG, H. G.; GEORGE, L. K.; PETERSON, B. L. Religiosity and remission of depression in medically ill older patients. **Am. J Psychiatry**, v. 155, n. 4, pp. 536-542, 1998.
- KOENIG, H. G.; MCCULLOUGH, M. E.; LARSON, D. B. **Handbook of religion and health**: a century of research reviewed. New York: Oxford University Press, 2001.
- LANCETTI, A.; AMARANTE, P. Saúde mental e saúde coletiva. In: CAMPOS, G. *et al.* (org.). **Tratado de saúde coletiva**. pp. 615-634. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec; Fiocruz, 2006.
- LARSON, R. W.; RICHARDS, M.; MONETA, G.; HOLMBECK, G.; DUCKETT, E. Changes in adolescents' daily interactions with their families from ages 10 to 18: Disengagement and transformation. **Developmental Psychology**, 32, pp. 744-754. 1996.
- LEVIN, J. S.; MARKIDES, K. S.; RAY, L. A. Religious attendance and psychological well-being in Mexican Americans: a panel analysis of three-generations data. **Gerontologist**, v. 36, n. 4, pp. 454-463, 1996.
- LIMA, A. F. **Contribuições da teoria de Ken Wilber para pensar a integralidade na educação**. 2014. 192 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.
- LUCCHETTI, G. *et al.* Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve saber? **Rev. Bras. Clin. Med.**, v. 8, n. 2, pp. 154-158, 2010.
- LUCZINSKI, G. F. **O psicólogo clínico e a religiosidade do cliente**: impactos na relação terapêutica. 2005. 190 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.
- MACHON, H. **O cristianismo em C. G. Jung**: fundamentos filosóficos, premissas psicológicas e consequências para a prática terapêutica. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2016.
- MARIE, J. N. **Introdução à suma teológica**. São Paulo: Loyola, 2004.
- MARQUES, T. G. **O desenvolvimento dos objetos transcendentais e da religião fundamentado nas obras de Freud e de Winnicott**. 2019. 161 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2019.
- MASLOW, A. **El hombre autorrealizado**. Barcelona: Kairós, 1983.
- MATTHEIWS, D. A. **The faith factor**: proof of the healing power of prayer. Washington: Penguin Books, 1998.
- MATTOS, R. A.; PINHEIRO, R. (org.). **Cuidado**: as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro, RJ: Hucitec; Abrasco, 2004.
- MCCRAE, R. R. O que é personalidade? In: FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 203-218. Porto Alegre: Artmed, 2006.

REFERÊNCIAS

- MCDONALD, D. A. Spirituality: description, measurement and relation to the Five Factor Model of Personality. **J Personality**, v. 68, n. 1, 2000.
- MENEZES, P. Origem do universo. **Toda matéria**, 2022. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/origem-do-universo/>. Acesso em: 8 nov. 2022.
- MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, pp. 7-18, 2000.
- MOREIRA-ALMEIDA, A.; CARDEÑA, E. Diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e psicóticas não patológicas e transtornos mentais: uma contribuição de estudos latino-americanos para o CID-11. **Rev. Bras. Psiquiatr.**, v. 33, supl. 1, pp. 21-28, 2011.
- MOSER, G. Psicologia ambiental. **Estud. Psicol.**, Natal, v. 3, n. 1, jan.-jun. 1998.
- MUELLER, P. S.; PLEVAK, D. J.; RUMMANS, T. A. Religious involvement, spirituality, and medicine: implications for clinical practice. **Mayo Clin. Proc.** 76(12):1189-1191, 2001.
- NASSER, M. C. C. **O uso de símbolos**: sugestões para sala de aula. São Paulo: Paulinas, 2006.
- NETTO, P. F. A. **Introdução à psicologia**. São Paulo: Livraria Nobel, 1974.
- NEWBERG, A.; LEE, B. The neuroscientific study of religious and spiritual phenomena: or why God doesn't use biostatistics. **Zygon**, v. 40, pp. 469-489, 2005.
- NUNES, M. A. S. M. **Recommender systems based on personality traits**. 2008. 143 f. Thesis (Doctorate on Computer Science) – Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, France, 2008.
- NUNES, C. H. S. S.; HUTZ, C. S.; NUNES, M. F. O. **Bateria Fatorial de Personalidade (BFP)**: manual técnico. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.
- OLIVEIRA, J. A. **Transcendência e religião no pensamento de H. C. de Lima Vaz**. 2014. 332 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Constituição**. Genebra: OMS, 1948.
- OSLER, W. The faith that heals. **Br Med. J.**, v. 1, n. 2581, pp. 1470-2, 18 jun. 1910. DOI: 10.1136/bmj.1.2581.1470.
- OTTO, R. **O sagrado**: os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. Tradução Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, 2007.
- OTTO, R. **O sagrado**: um estudo do elemento não/racional na ideia do divino e a sua relação com o racional. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1985.
- PANZINI, R. G. *et al.* Qualidade de vida e espiritualidade. **Rev. Psiq. Clín.**, v. 34, supl. 1, pp. 105-115, 2007.
- PAIVA, G. J. Ciência, religião, psicologia: conhecimento e comportamento. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p. 561-567, 2002.
- PETERLEVITZ, L. R. **O Deus Criador**: doutrinas bíblicas. Sumaré, SP: IBNC, 2007. Disponível em: http://www.novocoracao.com.br/ebd/7_O_Deus_criador_ibnc.pdf. Acesso em: 17 nov. 2022.
- PERVIN, L. A.; JOHN, O. P. **Personalidade**: teoria e pesquisa. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.



- PIEDMONT, R. L. Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. **J Personality**, v. 67, n. 6, 1999.
- PINHEIRO, M. R.; MATTOS, R. **Construção da integralidade**: cotidiano, saberes, práticas em saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: Abrasco, 2004.
- PINTO, E. B. Espiritualidade e religiosidade: articulações. **Rever - Revista de Estudos da Religião**, v. 9, pp. 68-83, 2009.
- PRINZIE, P. *et al.* The relations between parents' big five personality factors and parenting: a meta-analytic review. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 97, n. 2, pp. 351-362, 2009.
- PRADO, A. **Poesia reunida**. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2015.
- PRADO, A. Arte como experiência religiosa. *In*: MARINA, M.; MAHFOUD, M. (org.). **Diante do mistério**: psicologia e senso religioso. pp. 17-31. São Paulo: Loyola, 1999.
- PUCHALSKI, C.; ROMER, A. L. Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully. **J Palliat. Med.**, v. 3, n. 1, pp. 129-37, 2000.
- RASIC, D. T. *et al.* Spirituality, religion and suicidal behavior in a nationally representative sample. **J Affect Disord.**, v. 114, n. 11, pp. 32-40, 2009.
- REBOLLO, I.; HARRIS, J. R. Genes, ambiente e personalidade. *In*: FLORES-MENDOZA, C. E.; COLOM, R. (org.). **Introdução à psicologia das diferenças individuais**. pp. 300-322. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- ROCHA, J. R.; MONTEIRO, L. V. B. A dimensão espiritual na compreensão do fenômeno saúde-doença na psicologia da saúde. **Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT**, Alagoas, v. 4, n. 2, 2017.
- RODHEN, H. **O espírito da filosofia oriental**. São Paulo: Martin Claret, 2008.
- RÖHR, F. **Educação e espiritualidade**: contribuições para uma compreensão multidimensional da realidade, do homem e da educação. Campinas: Mercado de Letras, 2013.
- RÖHR, F. Espiritualidade e educação. *In*: RÖHR F. (org.). **Diálogos em educação e espiritualidade**. pp. 13-15. Recife: Ed. Universitária, 2010.
- RYAN, M. B. The transpersonal William James. **Transpers. Psychol. Rev.**, v. 40, n. 1, pp. 20-40, 2008.
- SAAD, M.; MASIERO, D.; BATTISTELLA, L. R. Espiritualidade baseada em evidências. **Acta Fisiátrica**, v. 8, n. 3, pp. 107-112, 2001.
- SAFRA, G. A vivência do sagrado e a constituição do *self*. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 6, n. 2, pp. 147-151, ago. 1998.
- SAFRA, G. **A poética na clínica contemporânea**. Aparecida: Ideias & Letras, 2004.
- SAFRA, G. Perspectivas do manejo clínico da experiência religiosa. *In*: ARCURI, I. G.; ANCONA-LOPEZ, M. (org.). **Temas em psicologia da religião**. p. 77-90, São Paulo: Vetor editora, 2007.
- SALDANHA, V. **A psicoterapia transpessoal**. São Paulo: Rosa dos Tempos, 1999.
- SANTOS, W. S. D. *et al.* A influência dos valores humanos no compromisso religioso. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 28, pp. 285-292, 2012.

REFERÊNCIAS

- SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: reflexões a partir da narrativa de um paciente. **Revista Medicina Integrativa**, 7 set. 2021. Disponível em: <https://revistamedicinaintegrativa.com/saude-e-espiritualidade-reflexoes-a-partir-da-narrativa-de-um-paciente/>. Acesso em: 24 out. 2022.
- SANTOS, W. S. *et al.* A influência dos valores humanos no compromisso religioso. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 28, n. 3, pp. 285-292, jul./set. 2012.
- SEIXAS, G. A saúde mental no trabalho: como compreender e aprender com os acontecimentos inesperados. **Sociomotiva**, [2021?]. Disponível em: <https://www.sociomotiva.com/pt-BR/pages/04f799e9-cd58-4333-9ac1-a07d4b69777b>. Acesso em: 18 out. 2022.
- SIQUEIRA, H. *et al.* Spirituality in the health-illness-care of the oncological user process: nurse's outlook. **Revista de Enfermagem UFPE**, v. 11, n. 8, pp. 2996-3004, jul. 2017.
- SILVA, J. L. L. S. O processo saúde-doença e sua importância para a promoção da saúde. **Informe em Promoção da Saúde**, v. 2, n. 1, pp. 3-5, 2006.
- SILVA, R. S. *et al.* Replicabilidade do modelo dos cinco grandes fatores em medidas da personalidade. **Mosaico: Estudos em Psicologia**, v. 1, n. 1, pp. 37-49, 2007.
- SILVA, M. B. A. M. *et al.* Espiritualidade e saúde: estudo caso-controle. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 14, n. 2, pp. 1201-1209, 2016.
- SILVA, M. A. Sistema sensorial. **Infoescola**, [20--?]. Disponível em: <https://www.infoescola.com/biologia/sistema-sensorial/>. Acesso em: 17 out. 2022.
- SMITH, T. B.; MCCULLOUGH, M. E.; POLL, J. Religiousness and depression: evidence for a main effect and the moderating influence of stressful life events. **Psychol. Bull**, v. 129, n. 4, pp. 614-36, 2003.
- SOUZA, R. D. O princípio da existência: uma abordagem da teologia protestante sobre Deus e o universo. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 7, ed. 7, v. 4, pp. 32-44, jul. 2022.
- STRAUB, R. O. **Psicologia da saúde**. Porto Alegre: Artmed, 2005.
- TEIXEIRA, E. Reflexões sobre o paradigma holístico e holismo e saúde. **Rev. Esc. Enf. USP**, v.30, n.2, p. 286-90, ago. 1996.
- TUPES, E. C.; CHRISTAL, R. E. Recurrent personality factors based on trait ratings. **Journal of Personality**, v. 60, pp. 225-252, 1992.
- VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- VOLCAN, S. M. A. *et al.* Relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, pp. 440-445, 2003.
- WILBER, K. **A visão integral**: uma introdução à revolucionária abordagem integral da vida, de Deus, do universo e de tudo mais. São Paulo: Cultrix, 2009.
- WILBER, K. **A prática de vida integral**: um guia do século XXI para saúde física, equilíbrio emocional, clareza mental e despertar espiritual. São Paulo: Cultrix, 2011.
- WULFF, D. M. **Psychology of religion**: classic & contemporary. New York: John Wiley & Sons, 1997.

